

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Consent Information - Patient Copy Laparostomy

الفتحة الجراحية في جدار البطن

1. What do I need to know about this procedure?

A laparostomy procedure is the re-opening of the abdominal wound and possible excision of any dead tissue.

2. My Anaesthetic.

This procedure will require an anaesthetic.

See **About Your Anaesthetic information sheet** for information about the anaesthetic and the risks involved. If you have any concerns, discuss these with your doctor.

If you have not been given an information sheet, please ask for one.

3. What are the risks of this specific procedure?

There are risks and complications with this procedure. They include but are not limited to the following.

General risks:

- Infection can occur, requiring antibiotics and further treatment.
- Bleeding could occur and may require a return to the operating room. Bleeding is more common if you have been taking blood thinning drugs such as Warfarin, Aspirin, Clopidogrel (Plavix or Iscover) or Dipyridamole (Persantin or Asasantin).
- Small areas of the lung can collapse, increasing the risk of chest infection. This may need antibiotics and physiotherapy.
- Increased risk in obese people of wound infection, chest infection, heart and lung complications, and thrombosis.
- Heart attack or stroke could occur due to the strain on the heart.
- Blood clot in the leg (DVT) causing pain and swelling. In rare cases part of the clot may break off and go to the lungs.

1. ما الذي ينبغي عليّ معرفته عن هذا الإجراء؟

يتم في هذا الإجراء إعادة فتح شق جراحي سابق في جدار البطن ، مع احتمال إزالة أي أنسجة ميتة.

2. التخدير الذي أتلقيه

قد يتطلب هذا الإجراء الخضوع للتخدير .

اقرأ تعليمات التخدير الموضعي والأدوية المسكنة المتعلقة بالإجراء الطبي المقرر لك .

للمزيد من المعلومات عن نوع التخدير والمخاطر المترتبة. إن كان لديك أي مخاوف أو تساؤلات قم بمناقشتها مع طبيبك المعالج. إذا لم تقدم لك ورقة التعليمات ، نرجو عدم التردد في طلبها .

3. ما هي المخاطر المتعلقة بهذا الإجراء بالتحديد ؟

لهذا الإجراء مخاطر ومضاعفات وتشمل ، ولكنها غير مقتصرة على :

مخاطر عامة:

- قد يحدث التهاب ، مما يتطلب العلاج بالمضادات الحيوية وعلاجات أخرى.
- حدوث نزيف مما قد يتطلب العودة مرة أخرى لغرفة العمليات لإيقافه. حدوث النزيف أكثر شيوعاً لدى من يتناولون العقاقير التي تؤدي لزيادة سيولة الدم مثل الوارفارين، الأسبرين، كلوبيدوجريل (بلافيكس أو اسكوفير) أو عقار دايابيردامول (بيرسانتن أو اساسانتين)
- قد يحدث إنغلاق لمناطق صغيرة في الرئة، مما يزيد من مخاطر الإصابة بالتهاب في الصدر، وقد يتطلب علاج ذلك استخدام المضادات الحيوية والعلاج الطبيعي (الفيزيائي) للصدر.
- عند المرضى ذو الأوزان الزائدة أو السمنة المرضية ، تزداد مخاطر الإصابة بعدوى والتهاب الجرح والصدر ، مضاعفات في القلب والرئة ، وجلطات الأوعية الدموية.
- قد ينتج عن إجهاد القلب حدوث أزمة قلبية أو سكتة دماغية.
- تجلط في أحد أوردة الساق (تجلط الوريد العميق للساق) مم يسبب ألم وتورم في الساق ، وفي حالات نادرة قد ينفصل جزء من التجلط ليصل إلى الرئة.

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Specific risks:

- Deep bleeding in the abdominal cavity could occur and this may need fluid replacement or further surgery.
- Damage of the bowel may occur which may cause leakage of bowel fluid. This may need further surgery.
- Infections such as pus collections can occur in the abdominal cavity. This may need surgical drainage.
- The bowel movement may be paralysed or blocked after surgery and this may cause building up of fluid in the bowel with bloating of the abdomen and vomiting. Further treatment may be necessary for this.
- Especially in a male there may be difficulty passing urine and a tube (catheter) may need to be inserted into the bladder until the bladder can empty normally.
- A weakness can occur in the wound with complete or incomplete, bursting of the wound in the short term or a hernia in the long term.
- In some people healing of the wound may be abnormal and the wound can be thickened and red and may be painful.
- Adhesions (bands of scar tissue) may form and cause bowel obstruction. This can be a short term or a long term complication and may need further surgery.

Notes to talk to my doctor about:

مخاطر خاصة بهذا الإجراء:

- نزيف عميق في التجويف البطني قد يستدعي إعطاء سوائل لتعويض الدم المفقود أو جراحة أخرى.
- قد يحدث ضرر للأعضاء مما قد يسبب تسرب سوائل الأعضاء. قد يتطلب ذلك جراحة أخرى.
- الإصابة بعدوى كتجمعات للصدية في التجويف البطني مما قد يتطلب تفريغ الصديد جراحياً.
- قد يحدث شلل لحركة الأمعاء أو قد تنسد الأمعاء مما يؤدي إلى تراكم السوائل فيها مع انتفاخ البطن والاستفراغ. يتطلب هذا الأمر معالجات أخرى.
- عند الذكور بصورة خاصة، قد تكون هناك صعوبة في إدرار البول بعد الجراحة، مما قد يتطلب وضع أنبوب (قسطرة بولية) في المثانة إلى أن تعود المثانة للإفراغ الطبيعي للبول. اثره مؤقت ونادر حصوله.
- ضعف قد يعترى الشق الجراحي ويؤدي على المدى القريب إلى تمزقه بشكل جزئي أو كامل، وعلى المدى البعيد قد يتسبب ذلك في نشوء فتق. ونادر حصوله.
- عند بعض المرضى، يحدث التئام الجرح بشكل غير طبيعي. قد تزداد سماكة الندب الجراحي ويصبح لونه أحمر وقد يكون مؤلماً.
- قد تحدث التصاقات وتسبب انسداداً للأمعاء. قد يحدث ذلك على المدى القريب أو البعيد وقد يحتاج حلاً جراحياً.

أمر أقوم بمناقشتها مع طبيبي المعالج
